Урок 5.4.

Пищевая непереносимость в гастроэнтерологии





Светлана Каневская

Доктор медицинских наук, профессор, основатель международной школы профессора Каневской

- в прошлом Медицинский руководитель в крупнейших мед.центрах Москвы премиум класса
- 25 лет опыта преподавательской работы со студентами медицинских ВУЗов, врачами и клиническими ординаторами
- 25 лет опыта практической работы с пациентами, в том числе с тяжелыми клиническими случаями

За годы своей практики

мной накопилен большой клинический опыт работы с пациентами, страдающими:

- Синдромом раздражённого кишечника, часто трудноподдающимся лечению
- Неспецифическими симптомами, выходящими за рамки стандартных нозологических диагнозов

Первая научная работа была посвящена **гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ)**

С чем ко мне обращаются?

- **Проблемы с желудочно-кишечным трактом:**
  - Боль, дискомфорт, вздутие, нарушение стула
  - Синдром раздражённого кишечника, гастрит, рефлюкс
- **Сложные и неясные случаи:**
  - Симптомы без чёткой причины
  - Состояния, не поддающиеся стандартной терапии
- **Общие проблемы, связанные с работой ЖКТ и плохим состоянием:**
  - Хроническая усталость, снижение качества жизни
  - Сопутствующие кожные, иммунные, психоэмоциональные проявления

О чем этот урок?

1. Пищевая непереносимость в гастроэнтерологии
2. Рекомендации по назначению теста
3. Ротационная диета - новый метод работы гастроэнтеролога
4. Клинический случай из практики

Пищевая непереносимость в гастроэнтерологии

Симптомы пищевой непереносимости со стороны ЖКТ **появляются не сразу, зависят от дозы** и **не связаны с аллергией.**

Симптомы могут напоминать воспалительные или функциональные заболевания кишечника.

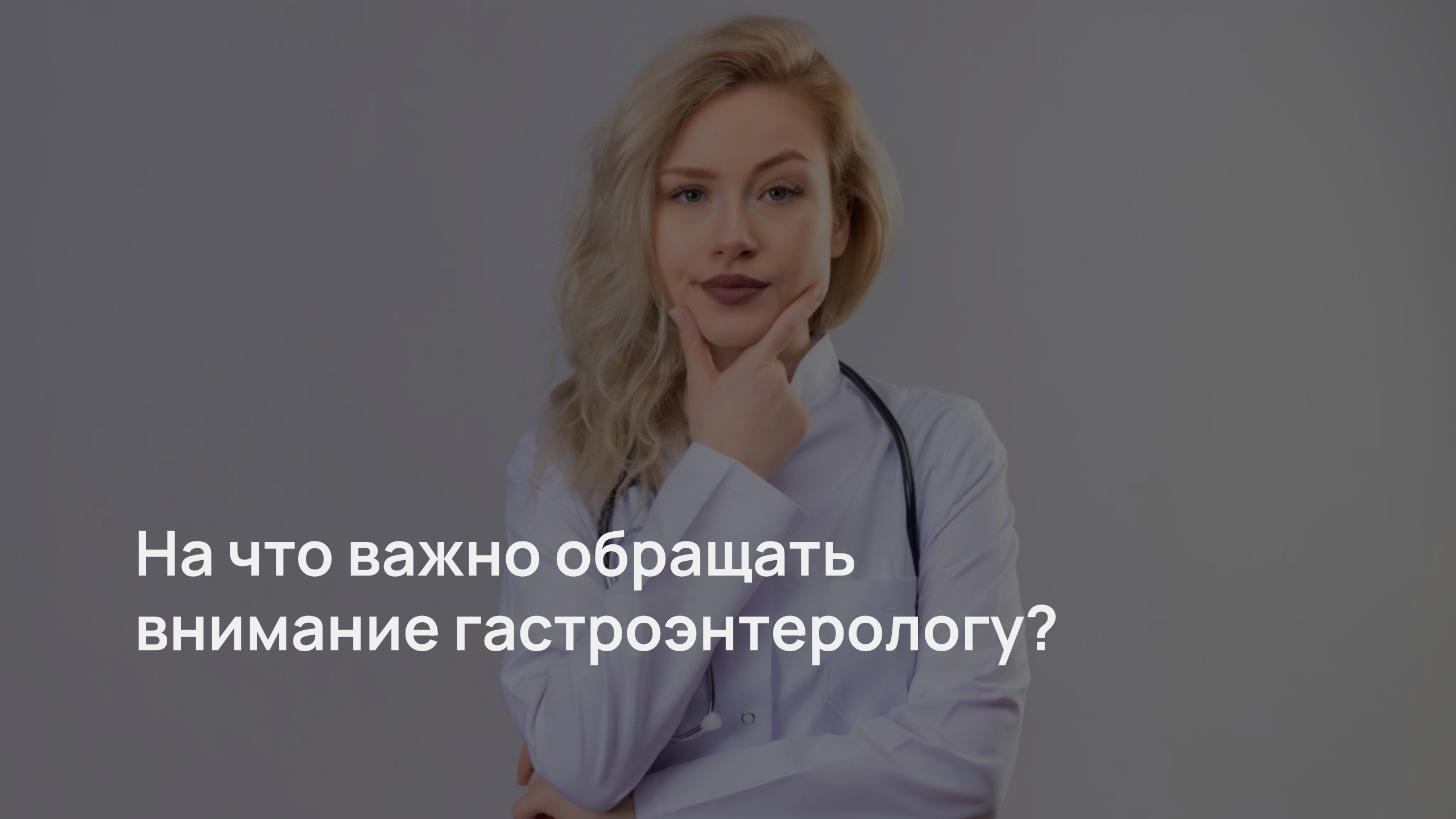
Причины — ферментные нарушения, дисбиоз, повышенная проницаемость кишечника, активация иммунитета и повышенная чувствительность кишечника.

Разберем основные симптомы и возможные механизмы пищевой непереносимости

	Симптомы	Возможный механизм
Ферментативная недостаточность	Вздутие, метеоризм, бурление, диарея после молока, фруктов	Дефицит лактазы, фруктозидазы, фермент DAO
Микробиотный дисбаланс (SIBO, дисбиоз)	Нестабильный стул, боли в животе, вздутие, «урчание»	Избыточная ферментация углеводов (FODMAP), метаногенные бактерии
Синдром раздражённого кишечника (СРК)	Альтернирующий стул, ощущение неполного опорожнения, слизь в стуле	Повышенная чувствительность рецепторов, висцеральная гиперреактивность

	Симптомы	Возможный механизм
Повышенная проницаемость кишечника (leaky gut)	Неспецифические симптомы + пищевые реакции на несколько продуктов	Нарушение tight junctions, транслокация антигенов
Гистаминовая непереносимость	Резкое вздутие, диарея, боли в эпигастрии, тошнота после ферментированных продуктов	Низкая активность DAO, накопление гистамина
Псевдо-аллергические реакции	Урчание, спазмы, диарея после специй, консервантов, вина	Неиммунная дегрануляция тучных клеток, салицилатная чувствительность

	Симптомы	Возможный механизм
Нецелиакическая чувствительность к глютену (NCGS)	Тяжесть, диарея, вздутие, затуманенность сознания, боли	Реакции врождённого иммунитета, нарушение барьера, повышение зонулина
Гистаминовая непереносимость	Рецидивирующие боли, нестабильный стул после перенесённого гастроэнтерита	Нарушения моторики и микробиоты после перенесённой инфекции



На что важно обращать внимание гастроэнтерологу?

На что важно обращать внимание?

- Отсроченный ответ (через 2–72 ч после приёма пищи)
- Симптомы усиливаются при стрессах или на фоне гормональных колебаний (ПМС)
- Чёткая связь с типами пищи (молочные, злаки, бобовые, вина, специи)
- Симптоматика уменьшается на диете с исключением триггера
- При обследовании (ФГДС, УЗИ, КТ, колоноскопия) – отсутствие органической патологии

Какие анализы могут помочь?

Анализ	Возможное изменение при ПН
Фекальные маркеры (SCFA, кальпротектин, эластаза)	Пограничные или субклинические отклонения
Зонулин, DAO	Повышение зонулина, снижение DAO
Дыхательные H_2/CH_4-тесты	Положительные при лактазной недостаточности, SIBO
Микробиота (qPCR, NGS)	Уменьшение видов-протекторов, избыток условно-патогенных

Задача гастроэнтеролога

- **Исключить целиакию**, органические заболевания и IgE-аллергию
- **Назначить элиминационно-провокационную диету**, здесь врачу помогает FOX-на пищевую непереносимость
- **Поддержать** слизистую, микробиоту и ферментативную функцию
- **Сформировать** персонализированную нутритивную **стратегию**

Какие могут быть показания к назначению теста?

Критерий/Симптом	Пояснение и патогенетическая связь
1) **Функциональные ЖКТ-жалобы**	СРК, вздутие, метеоризм, диарея/запор без органической причины
2) **Отсроченная реакция на пищу (2–48 ч после приёма)**	Нет немедленной IgE-реакции, но есть повторяемый симптом
3) **Хронический субклинический воспалительный фон**	Повышение фекального кальпротектина/зонулина

Какие могут быть показания к назначению теста?

Критерий/Симптом	Пояснение и патогенетическая связь
4) **Симптомы после продуктов с биогенными аминами**	Реакции на вино, сыр, бананы, копчёности, шоколад — дефицит DAO
5) **Мигрени, головные боли, тревожность, нарушения сна**	Пищевые триггеры ЦНС через кишечник (ось “кишечник–мозг”)
6) **Рецидивирующая крапивница/ экзема без IgE-аллергии**	Пищевые псевдоаллергии, салицилаты, гистамин

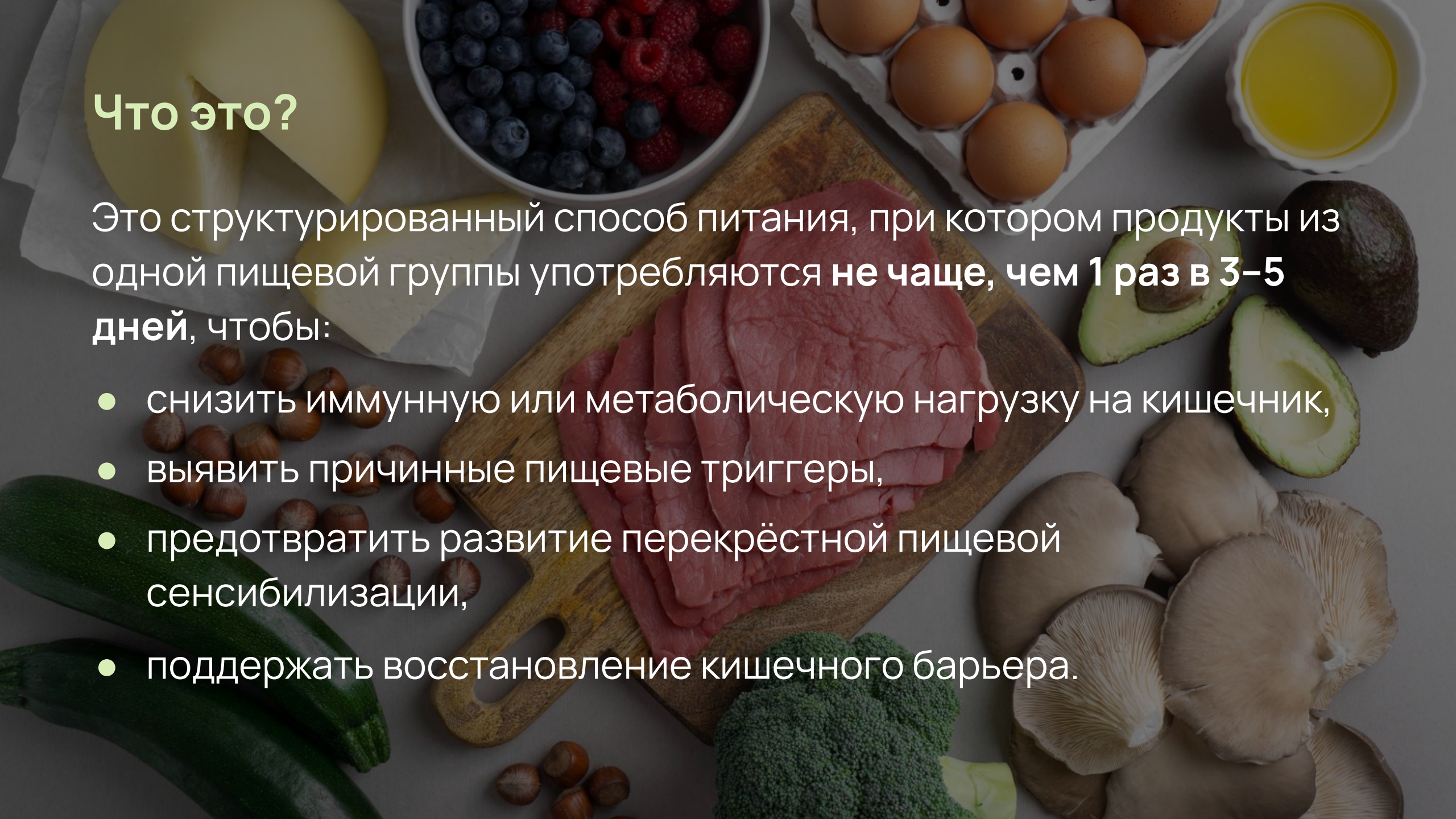
Какие могут быть показания к назначению теста?

Критерий/Симптом	Пояснение и патогенетическая связь
7) **Отсутствие эффекта от терапии СРК/ диспепсии**	Подозрение на скрытый иммунный или ферментативный компонент
8) **Ранее перенесённый энтерит/ SIBO / дисбиоз**	Нарушение толерантности к FODMAP и белкам
9) **Множественные пищ. реакции, непереносимость диет**	Пациенты с гиперчувствительностью к большому числу продуктов

Когда тест точно не нужен

- Если уже поставлен **точный диагноз** в соответствии с клиническими рекомендациями
- При наличии **гистологического подтверждения** заболевания
- При подтверждённой **целиакии, непереносимости лактозы или других пищевых непереносимостей**, подтверждённых генетическими тестами

Ротационная диета



Что это?

Это структурированный способ питания, при котором продукты из одной пищевой группы употребляются **не чаще, чем 1 раз в 3–5 дней**, чтобы:

- снизить иммунную или метаболическую нагрузку на кишечник,
- выявить причинные пищевые триггеры,
- предотвратить развитие перекрёстной пищевой сенсибилизации,
- поддержать восстановление кишечного барьера.

Механизм	Обоснование
Снижение антигенной нагрузки	Время между экспозицией белков (3–5 дней) позволяет избежать накопления IgG-комплексов и воспалительной стимуляции
Восстановление DAO/энтераза	При дефиците ферментов (DAO, лактаза) перерывы уменьшают выраженность симптомов
Снижение сенсибилизации	Частое употребление одного продукта увеличивает риск клонального ответа лимфоцитов
Поддержка микробного разнообразия	Ротация разных волокон и белков питает разнообразные метаболические ниши микробиоты

Какие показания к назначению?

Показания к назначению ротационной диеты

- Подозрение на множественные пищевые непереносимости (особенно IgG-зависимые)
- После исключающей диеты (например, FODMAP, безглютеновой)
- Гистаминовая чувствительность, DAO-дефицит
- При синдроме повышенной проницаемости кишечника
- После инфекционного гастроэнтерита / SIBO
- При крапивнице и кожных реакциях без IgE-аллергии

Пошаговая методология внедрения ротационной диеты



Шаг 1. Группировка продуктов по биологическому семейству и антигенному профилю

Например:

- **Злаки**: пшеница, рис, кукуруза, гречка, овёс, киноа
- **Овощи**: крестоцветные, паслёновые, корнеплоды
- **Фрукты**: цитрусовые, косточковые, ягоды
- **Белки**: говядина, курица, индейка, рыба, яйца
- **Орехи/семена**: миндаль, грецкий, тыквенные, подсолнечные
- **Молочные/заменители**: козье, кокосовое, миндальное

Шаг 2. Разделение на 4-дневные блоки (ротации)

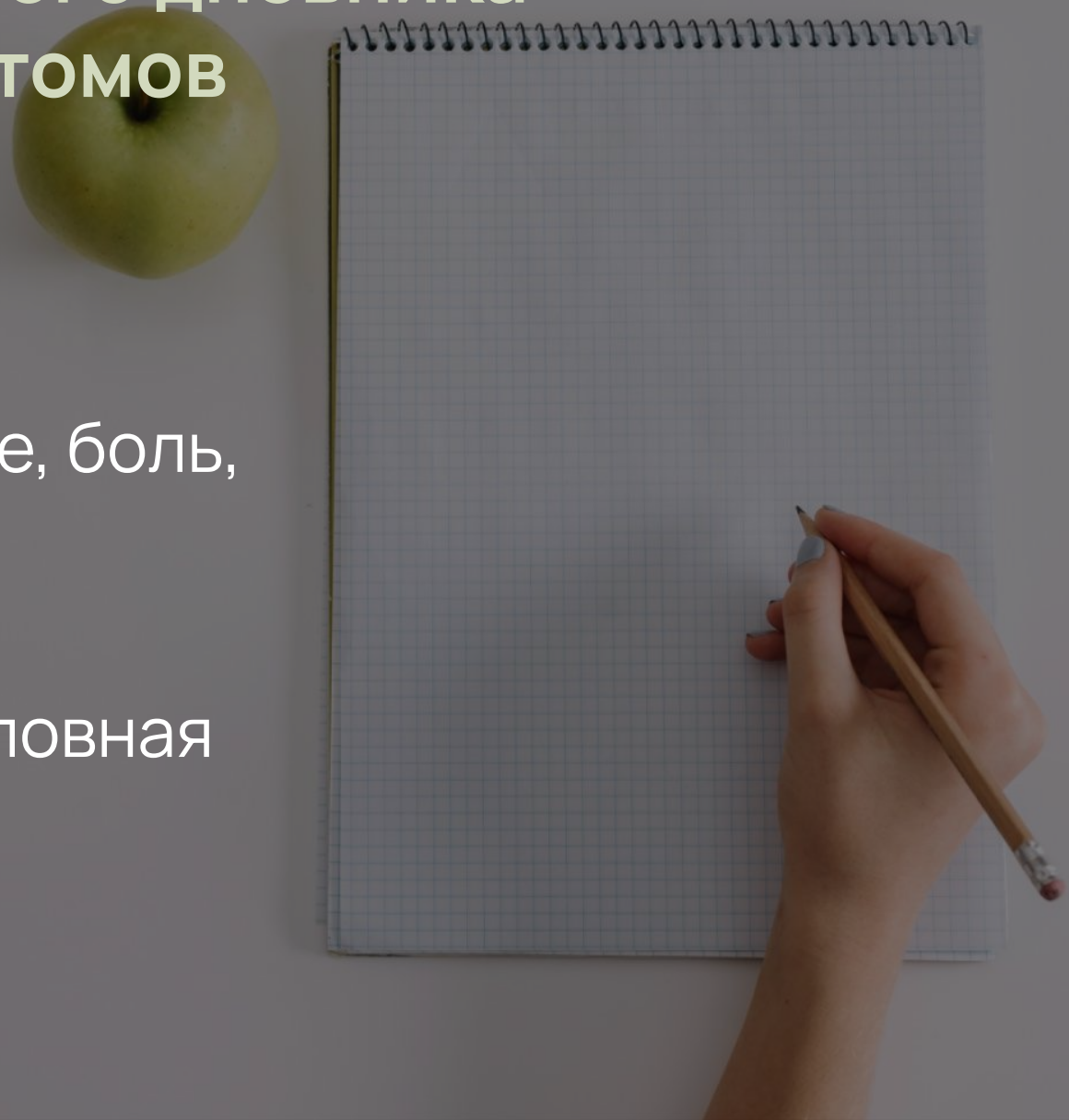
День	Белок	Злак	Овощ	Фрукт	Орех/жир
1	Говядина	Рис	Брокколи	Яблоко	Миндаль
2	Рыба	Гречка	Кабачок	Банан	Тыквенные
3	Индейка	Киноа	Морковь	Груша	Подсолнечные
4	Яйцо	Овёс	Батат	Черника	Кокос

Через 4 дня цикл повторяется с изменением меню внутри групп.

Шаг 3. Ведение пищевого дневника и отслеживание симптомов

Пациент записывает:

- Продукт, время приёма
- ЖКТ-симптомы (вздутие, боль, стул)
- Общие проявления (утомляемость, зуд, головная боль)



Что исключается при ротационной диете? (на этапе диагностики)

- Часто потребляемые и подозреваемые **триггеры** (например, глютен, коровье молоко, соя)
- **Высокогистаминовые продукты:** ферментированные, вино, шоколад
- **Продукты с добавками** (глутамат, сульфиты)

Как и когда оценить эффективность?

Оценка эффективности

Через 3–4 недели:

- Симптоматика уменьшается на >50% — высоковероятная пищевая чувствительность
- Далее возможна **провокационная проба** или **подтверждение по лабораторным тестам:**

➔DAO,т .е. диаминоксидаза, ключевой фермент, метаболизирующий гистамин

➔зонулин

➔SCFA (короткоцепочечные жирные кислоты)

Клинические особенности

- Диета **не является пожизненной** — применяется **в диагностических и восстановительных целях**
- При чрезмерных ограничениях — риск нутритивного дефицита
- Требует **наблюдения врача + нутрициолога**

Ротационная диета позволяет:

- выявлять триггеры пищевой непереносимости
- снижать иммунную и ферментативную нагрузк,
- **персонализировать питание** без гиперограничений



Пациент

Пол: женский

Возраст: 44 года

Пищевая непереносимость, NCGS и восстановление качества жизни

Жалобы

- **Ежедневные головные боли**, преимущественно к вечеру
- **Вздутие живота**, тяжесть после еды, нерегулярный стул
- **Хроническая усталость**, особенно в утренние часы
- **Повышенная тревожность, раздражительность**
- **Нарушение сна**, частые пробуждения, поверхностный сон
- **Постоянное ощущение "разбитости"**, снижение работоспособности
- Принимала НПВС до 3 раз в неделю

Анамнез

- **Невролог** и **гастроэнтеролог** в течение 12 мес. проводили стандартное обследование: МРТ головного мозга, УЗИ органов брюшной полости, ЭГДС — патологии не выявлено
- Лабораторные показатели: в пределах нормы, антитела к tTG, DGP и HLA-DQ2/8 — **отрицательные**
- Диагноз не был установлен. Применялись диеты FODMAP, спазмолитики, пробиотики, психотерапия — **без эффекта**

Почему был назначен тест?

- Множественная симптоматика без диагноза
- Подозрение на **иммунную пищевую гиперреактивность замедленного типа (IgG)**, в т.ч. **нецелиакийную глютеновую чувствительность**
- Возможное участие **синдрома повышенной кишечной проницаемости (LGS)** в поддержании воспаления

Результаты теста FOX

В «красной зоне» (IgG > 30–50 мкг/мл):

- Все молочные белки (казеин, β-лактоглобулин, α-лактальбумин)
- Коровье, козье, овечье, буйволиное молоко, все сыры (моцарелла, гауда, камамбер и др.)
- Яичный белок и желток
- Глютен, пшеница (в т.ч. полба, глиадин, пшеница однозернянка), овёс — выраженные значения
- Помидор, икра, мёд, горчица — в умеренно повышенных значениях

А также

- **Серология на целиакию:** tTG IgA/IgG, DGP – отрицательные
- **Генетика:** HLA DQ2/DQ8 – отрицательные

Выстроенная практика

Этап 1 (первые 4 недели):

- Полное исключение **всех молочных продуктов**, включая скрытые источники
- Симптомы частично уменьшились (головные боли 2–3 раза в неделю вместо ежедневных)

Выстроенная практика

Этап 2 (с 5 недели):

- Введена **строгая безглютеновая диета**: исключены все источники пшеницы, глютена, овса
- Исключены также помидоры, мёд, горчица, икра

Дополнительно назначено

- **L-глутамин** 5 г × 2 раза/сут
- **NAG (N-ацетилглюкозамин)** 500 мг × 2
- **Пробиотик** мультиштамм (без лактозы и глютена)
- **Цинк-карнозин**, **дигидрокверцетин**, **ферментный комплекс**

Результаты через 1 месяц

после отмены глютена:

- Симптоматика уменьшилась на ~50%
- Ушла утренняя усталость, нормализовался стул, снизилась тревожность

Результаты через 3 месяца

Через 3 месяца:

- **Головные боли полностью купировались**
- **Нормализовался сон**, исчезло ощущение разбитости
- Пациентка **отказалась от регулярного приёма НПВС**
- Вернулась к нормальному режиму работы и физической активности

Предположительный прогноз при отсутствии диагностики:

- Продолжение назначений симптоматических препаратов
- Потенциальное прогрессирование системного воспаления
- Нарушение психоэмоционального фона и развитие тревожных расстройств



В этом уроке мы:

- Роль **пищевой непереносимости в гастроэнтерологии** и её влияние на течение заболеваний ЖКТ
- **Рекомендации по назначению теста** на пищевую непереносимость в клинической практике
- Принципы и преимущества **ротационной диеты** как современного метода в работе гастроэнтеролога
- Практический разбор **клинического случая**, демонстрирующий эффективность комплексного подхода